

Fecha Última Actualización: 22-06-2022 14:25:13

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Lisandro Ernesto Hernández Reyes
Edad : 30a 3m 10d
Dirección : Pje. Dalcao 2429

Rut : 18.290.559-3
Fecha Nacto: 12/03/1992
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2209535
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7227 4333

N° Epicrisis
310860

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 14/05/2022 16:37

Días Estadía: 39

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 22/06/2022 16:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

insuficiencia respiratoria

Comorbilidades

Obesidad;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI SU CASR: 14/05/22
FI UCI: 14/05/22
FI UTIM: 11/06/22
Re-ingreso UCI 14/06/2022
Re-ingreso UTIM: 16/6/2022
FI SALA: 20/06/22

ANTECEDENTES

- MÉDICOS: Obesidad
- QUIRÚRGICOS: No
- FÁRMACOS: No
- ALERGIAS: No
- HÁBITOS: tabaquismo ocasional, máx 3 cigarros día ¿ OH no ¿ Drogas no
- INMUNIZACIONES: COVID19 x3
- HOSPITALIZACIONES RECIENTES: No
- SOCIAL: Autovalente, trabaja en construcción de cercos en Santiago, familia vive en Cañete
- ANTECEDENTES FAMILIARES: No

MOTIVO DE CONSULTA: Disnea + dolor torácico

ANAMNESIS PRÓXIMA

Paciente sin antecedentes relevantes, consulta por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por dolor torácico tipo puntada EVA 7/10 en hemitórax derecho con tope inspiratorio e irradiado a zona interescapular; consulta en APS donde es derivado a CASR por insuficiencia respiratoria (sat 88% con Fr 44x).

Ingresa en regulares condiciones generales, hemodinámicamente estable con tendencia a la hipertensión 147/91 PAM 109 taquicárdico 107 lpm, subfebril 37°C sat 98% pero con 15 litros por MAF. Al examen físico se describe hidratado y bien perfundido, MP simétrico, sin UMA pero FR 33x.

Se solicitan exámenes de laboratorio en los que destaca: Ac. láctico 13 albumina 3.9 calcio 8.9 creatinina 0.87 BUN 12.8 ELP 134/4.35/102 glucosa 106 PCR 29.2 Hb 15.7 leucocitos 17.240 plaquetas 293.000 pH 7.37 PCO2 43 PO2 46.5 bic 24.5 BE -0.7 PCR Sars Cov2 negativa

Fecha Epicrisis : 22/06/2022 14:25

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 22-06-2022 14:25:13

Página 2 de 3

- AngioTAC tórax: Examen sin evidencia de síndrome aórtico agudo ni de tromboembolismo pulmonar agudo hasta nivel lobar. Foco de condensación en el LID que impresionan parte determinado por atelectasia y neumonía. Derrame pleural laminar a derecha. Acentuada esteatosis hepática difusa.

Evolución tórpida con desaturación hasta 88% y taquipnea 44 a pesar de altos requerimientos de O2 por lo que se intuba en UEA y se traslada a UCI.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1. Shock séptico foco pulmonar. Neumonía adquirida en la comunidad ATS ¿ IV
- a. Falla respiratoria
2. Antecedentes: Obesidad tipo 2

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN:

Hemodinámico: requiere NAD hasta 0.1 con rápido descenso, en relación a sedoanalgesia, que se logra suspender el 19/05. Evolucionando HDE, Hb 14.1, VEC aumentado, recibe furosemida para BH -500 a -1000.MNI.

Respiratorio: IOT 14/05 por taquipnea y desaturación, sin alteración de intercambio gaseoso. Por cuff disfuncional se cambió TOT el 19/05. Evolucionando con caída de PAFI hasta 190 por lo que se controla TAC que evidenció atelectasia de pulmón derecho, se realizó FBC el 20/05 que evidenció tapones mucosos que se aspiraron. Evolucionando con PAFI persistentemente baja (200) sin evidencia de sobreinfección por lo que se controló TAC que no evidenció TEP hasta nivel segmentario proximal y se reportó moderado derrame pleural derecho, de similar cuantía respecto a examen previo. Mínimo derrame pleural izquierdo. Opacidades parenquimatosas condensantes bilaterales, con menor extensión de la opacidad del lóbulo superior derecho y mayor extensión de la opacidad del lóbulo inferior izquierdo. Persiste sin progresar en Weaning por PAFI baja por lo que 01/06 se realiza nueva FBC que se describe sin lesiones y con pocas secreciones, pero se evidencia en bases signos de compresión extrínseca. TAC: Leve a moderado derrame pleural derecho, sin cambios significativos en comparación a estudio previo. Leve derrame pleural izquierdo sin cambios. Atelectasia pasiva del lóbulo inferior derecho asociado a secreciones endobronquiales en el lóbulo inferior derecho, hallazgo que puede estar en contexto de un foco de neumopatía sobreagregado. Adenopatías mediastínicas, probablemente de carácter reactivo. 02/06 se realiza punción por radiología intervencional con salida líquido citrino. Tras la segunda FBC mejora en intercambio gaseoso, pasando a modalidades espontáneas y finalmente extubación el 09/06 saliendo a CNAF que ha ido en lento descenso. Se traslada a UTIM, para continuar manejo y rehabilitación el 11/06, estable pero el 14/06 comienza rápidamente de forma abrupta con falla respiratoria, caída de PaFI a 90 y polipneico, requiere reintubación y volver nuevamente a UCI. Se realiza AngioTC 13/6 que descarta TEP, e informa atelectasias segmentarias en ambos lóbulos inferiores. Paciente se autoextuba en UCI en menos de 24 horas. Logra consolidar auto weaning y suspender O2, saliendo nuevamente a UTIM. Se traslada a sala el 20/06, evolucionando tranquilo, con requerimientos de O2 en descenso, logrando suspensión hace más de 24 horas.

Infeccioso: Se cubre inicialmente con ampicilina sulbactam, a las 48 horas se agrega macrólido por gravedad. 22/05 cursa con fiebre por lo que se cultiva, sin cambio en esquema antibiótico, completa 8 días de ampicilina sulbactam y 7 de azitromicina. Evolucionando afebril y con lento descenso de PPII hasta fines de mayo donde vuelve a presentar alza de PPII y fiebre, se cultiva e inicia de forma empírica Vancomicina e imipenem, de dichos cultivos se rescata ambos HC periféricos (+) para Sep R cloxa, clinda y eritromicina además de S. haemolyticus MR (S vancomicina) en punta CVC, 15 UFC. Discutido con infectología, en relación a procedimientos, 02/06 se decide rotar esquema a Meropenem por riesgo de infección por Burkholderia cepacia (previo a rescates de cultivos 29/05, queda sin cobertura CGP), con cultivos se vuelve a agregar vancomicina, completa 7 días Meropenem el 09/06 y se mantiene vancomicina completando 7 días. Desde la suspensión de ATB, afebril, parámetros inflamatorios bajos.

Renal: Sin disfunción, durante hospitalización cursa con hipokalemia e hiponatremia, además BH acumulado +11.000. Últimos exámenes 19/6 sin trastornos ELP, sin falla renal. Procurar BH negativo, seguimiento ELP.

Psiquiátrico: se describe en UCI paciente con trastorno ansioso en manejo con Olanzapina y Clonazepam, además de metadona, sin evaluación por psiquiatría. Se describe sin agitación con dicho esquema por lo que de momento mantengo, envío IC a Psiquiatría para evaluación

Rehabilitación: se mantiene en seguimiento por Fonoaudiología, Kinesioterapia.

Fecha Epicrisis : 22/06/2022 14:25

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:17

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 22-06-2022 14:25:13

Página 3 de 3

DIAGNÓSTICOS DE TRASLADO

1. Insuficiencia respiratoria aguda parcial resuelta
 - 1.1. Neumonía adquirida en la comunidad ATS IV tratada
 - 1.1.1. IOT 14/05 ¿ 09/06/ Re IOT 14/06-15/06
 - 1.1.2. Atelectasias segmentarias bilaterales.
 2. Derrame pleural paraneumónico, con Bacteremia por SEP R 29/05 tratado
 3. ITS CVC S. haemolyticus
 4. Paciente crítico crónico
 - 4.1. Miopatía paciente crítico en evolución
 - 4.2. Trastorno de la deglución resuelta
 5. Esteatosis hepática
 6. Antecedentes: Obesidad

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) - Grave, Requerimientos lot

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en BCG, HDN estable, afebril, sin requerimientos de oxígeno suplementario.
Niega dolor ni otras molestias.

Plan Post Alta

Reposo relativo
Régimen liviano
O2 SOS para SpO2 > 92%
Kinesioterapia motora y respiratoria.

Medicamentos:

- Bromuro Ipratropio/fenoterol 2 puff cada 6 horas AEC por 7 días, y luego evaluar suspensión.
- Quetiapina 12.5 mg en la noche VO por 7 días, luego suspender.
- Clonazepam 0.5 mg en la noche VO por 7 días, luego suspender.

Controles:

- Seguimiento en APS de cuidados y ajustes de medicamentos.
- Acudir a urgencia SOS.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos :

Controles

S/F - APS - - ajuste de medicamentos, suspensión Benzodiacepinas

INTERNO

Becado/Residente



Jorge Verdugo Muñoz
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 22/06/2022 14:25

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:17

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar